

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Ricostruzione DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa la parte principale della pagina. La Base Analysis viene riportata in parallelo nella colonna laterale soltanto quando esiste un significato documentale da analizzare.

Struttura del case study

Il documento segue la progressione DDTA dal contesto generale del progetto agli elementi documentali successivi. Ogni elemento viene presentato nella colonna documentale; la colonna Base Analysis mostra esclusivamente l'analisi derivabile da quel significato, senza introdurre fatti di progetto aggiuntivi.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

Base Analysis

Il contesto generale definisce il problema affrontato dal progetto, ma non introduce ancora un elemento documentale strutturato da decomporre in referenti e proposizioni. La Base Analysis viene quindi applicata a partire dagli elementi DDTA successivi, quando il significato governato rende identificabili responsabilita', relazioni, condizioni o risultati analizzabili.

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorit  operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilit  e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorit  operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale dell'MR.

Domande sulla documentazione

- HIGH / MEDIUM / LOW   una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure   comportamento interno della pipeline image-based?

3 DEC-MR01-01 - Continuità' del triage senza immagine

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Le informazioni disponibili sul caso possono includere oppure non includere un'immagine della lesione.

Decision

DermaTriage mantiene disponibile la valutazione di triage anche in assenza di un'immagine della lesione, utilizzando le informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Consequences

L'assenza dell'immagine non interrompe automaticamente la responsabilità di triage. La documentazione non stabilisce che il percorso senza immagine debba produrre tutti gli stessi risultati del percorso image-based.

Domande sulla documentazione

- Che cosa costituisce esattamente una immagine assente o non disponibile?
- Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili?
- E' richiesta equivalenza di output fra percorso con immagine e percorso senza immagine?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

4 DEC-MR01-02 - Dominio di priorit  operativa P1-P4

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

MR-01 richiede una priorit  operativa di triage; la documentazione di progetto usa il dominio P1-P4 per rappresentarla.

Decision

DermaTriage rappresenta la priorit  operativa di triage mediante la scala P1-P4.

Consequences

La Decision governa il dominio della priorit  operativa. Non incorpora automaticamente la regola completa urgency/confidence-to-P, le soglie numeriche, i tempi SLA o la loro semantica normativa.

Domande sulla documentazione

- Qual e' la regola completa che mappa urgenza e confidence sulla P-scale?
- La soglia di confidence e' un parametro configurabile o una regola governata?
- I valori temporali associati a P1-P4 sono SLA normativi, target o semplici valori documentati?
- Chi governa l'eventuale trigger e l'owner degli SLA?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

5 DEC-MR01-03 - Architettura analitica image-based a quattro stadi

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Nel percorso image-based la documentazione descrive una sequenza di quattro stadi analitici che contribuiscono alla sintesi di triage.

Decision

DermaTriage costruisce la valutazione image-based mediante una pipeline analitica sequenziale a quattro stadi, nella quale i risultati intermedi contribuiscono alla successiva sintesi di triage.

Consequences

La Decision governa la struttura sequenziale a quattro stadi. Nomi di modelli, prodotti, vector store e altri binding concreti non definiscono da soli l'identita' della Decision.

Domande sulla documentazione

- E' governato il numero esatto di quattro stadi o soltanto la separazione delle funzioni analitiche?
- L'ordine degli stadi e' un commitment stabile oppure una proprieta' della realizzazione corrente?
- Quali responsabilita' appartengono alla Decision e quali restano comportamento interno dei singoli stadi?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

6 DEC-MR01-04 - Separazione tra sintesi analitica e priorit  operativa

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

La pipeline analitica produce una sintesi di urgenza; la documentazione rappresenta separatamente la successiva derivazione della priorit  operativa.

Decision

Nel percorso image-based, DermaTriage mantiene distinta la sintesi analitica di urgenza dalla successiva derivazione della priorit  operativa di triage.

Consequences

La Decision governa il boundary fra risultato analitico e risultato operativo. Il dominio P1-P4 resta governato dalla Decision precedente; mapping, soglie e SLA restano significati distinti da analizzare al livello appropriato.

Domande sulla documentazione

- La separazione   un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline?
- La priorit  operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall'ultimo stadio senza violare un commitment documentato?
- Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

7 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione né la responsabilità di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro è sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande sulla documentazione

- Qual è il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- È documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non è ancora stata eseguita. Il successivo passaggio analitico dovrà consumare soltanto il significato qui documentato, preservando lo STOP AT MR e senza inferire regole di selezione specialistica mancanti.

8 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico può validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilit  il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non   ancora stata eseguita. Nel passaggio successivo dovr  essere verificato quali referenti e relazioni siano realmente derivabili dal significato documentato, senza introdurre una semantica della revisione clinica non stabilita dalla documentazione.

Domande sulla documentazione

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

9 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire l'adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte.

Context

Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L'evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita' correnti di realizzazione di questa responsabilita' e non ne definiscono l'identita' macro.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili.

OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

MR-03

Domande sulla documentazione

- Quale evidenza clinica e' sufficiente per attivare l'adattamento?
- Chi autorizza l'adozione del comportamento adattato?
- Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita' sono governati?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Il successivo passaggio dovra' preservare la dipendenza semantica da MR-03 senza trasformarla in containment o co-ownership e senza promuovere automaticamente i meccanismi correnti di adattamento a responsabilita' macro autonome.

10 Indice di integrità' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	ccabe4bed7cca4d2f68a2005e42f36e3
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	0fb76dc0491da2793823b20571e5268b
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	3c912396a2040761bc527a68c3bf6205
4	DEC-MR01-01 - Continuità del triage senza immagine	fbe6f183b7501edb3e0daee2c0cae244
5	DEC-MR01-02 - Dominio di priorità operativa P1-P4	b5827a6b82bf6de3eabec1812725aee9
6	DEC-MR01-03 - Architettura analitica image-based a quattro stadi	4cfdee2dc8f843e8c7f7d4cdb27a8685
7	DEC-MR01-04 - Separazione tra sintesi analitica e priorità operativa	fc93e5efeca4d22bacd55d5b345a394a
8	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	abf9008d770509039fc7ffbd1cf1f655
9	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	589ab9dd2fc47da8ed0c64692eb2a76d
10	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	58aca712eadb3222507468f39fae50fe
11	Indice di integrità delle pagine	503e68b51c6310459cab3eb12c56469d

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.